TỔNG QUAN VỀ XẸP PHỔI
(dịch từ sách CĐHA của Cambridge)

HÀ TRẦN HỒNG QUẢNG · 28-05-2017

I) TỔNG QUAN.

• Xẹp phổi là mất nhu mô phổi do giảm thông khí. Xẹp phổi đồng nghĩa với sự sụp đổ.

• Dấu hiệu trực tiếp của xẹp phổi là sự biến mất của nhu mô và bao gồm:
o Dịch chuyển các rãnh liên thùy.
o Chèn ép mạch.

• Những dấu hiệu gián tiếp của xẹp phổi do sự mất thể tích nhu mô lên các cấu trúc lân cận bao gồm:
o Nâng cao cơ hoành.
o Tăng số lượng cung sườn trên mặt xẹp.
o Dịch chuyển trung thất sang bên xẹp.
o Tăng hoạt động thùy liền kề hoặc đối bên.
o Dịch chuyển rốn phổi.

• Khí trong phế quản không thấy trong xẹp phổi nếu nguyên nhân là tắc nhánh phế quản trung tâm, nhưng có thể thấy trong xẹp phổi phân thùy. Xẹp phổi phân thùy là do tắc nghẽn phế quản ngoại vi, thường do dịch tiết.

• Xẹp phổi phân thùy và sốt nhẹ thường gặp ở bệnh nhân sau phẫu thuật, mặc dù chưa có nghiên cứu nào chỉ ra mối liên hệ giữa xẹp phổi và sốt sau mổ.

II) CƠ CHẾ CỦA XẸP PHỔI.

• Xẹp phổi tắc nghẽn xảy ra khi khí phế nang được hấp thu qua mao mạch phế nang nhưng không được thay thế bởi không khí mới do tắc nghẽn phế quản.
o Xẹp phổi tắc nghẽn có thể dẫn tới xẹp phổi thùy, xẹp hoàn toàn 1 thùy phổi sẽ được nhắc đến ở phần sau.
o Xẹp phổi tắc nghẽn xảy ra nhanh hơn khi bệnh nhân thở oxy vì oxy được hấp thụ qua phế nang nhanh hơn so với nito.
o Nói chung xẹp phổi tắc nghẽn liên quan đến việc mất mát khối lượng. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân ICU nặng có thể có sự ngấm nhanh chóng dịch vào phế nang dẫn đến lu mờ chẩn đoán.
o Ở trẻ em, tắc nghẽn đường thở thường do hít phải dị vật. Ngược lại với người lớn, ở trẻ em lan rộng ra các vùng liên quan với hiệu ứng bóng van.
o Xẹp phổi phân thùy là kiểu phụ của xẹp phổi tắc nghẽn, thường thấy sau phẫu thuật hay bệnh tật nói chung, do chất nhầy tắc nghẽn đường thở.

• Xẹp phổi giãn ra (thụ động) là do giãn ra của phổi liền kề với một tổn thương trong ngực gây hiệu ứng khối như tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, u phổi.

• Xẹp phổi dính là do thiếu hoạt chất bề mặt.
o Gặp nhiều nhất trong hội chứng suy hô hấp sơ sinh, nhưng cũng có thể gặp trong hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) .

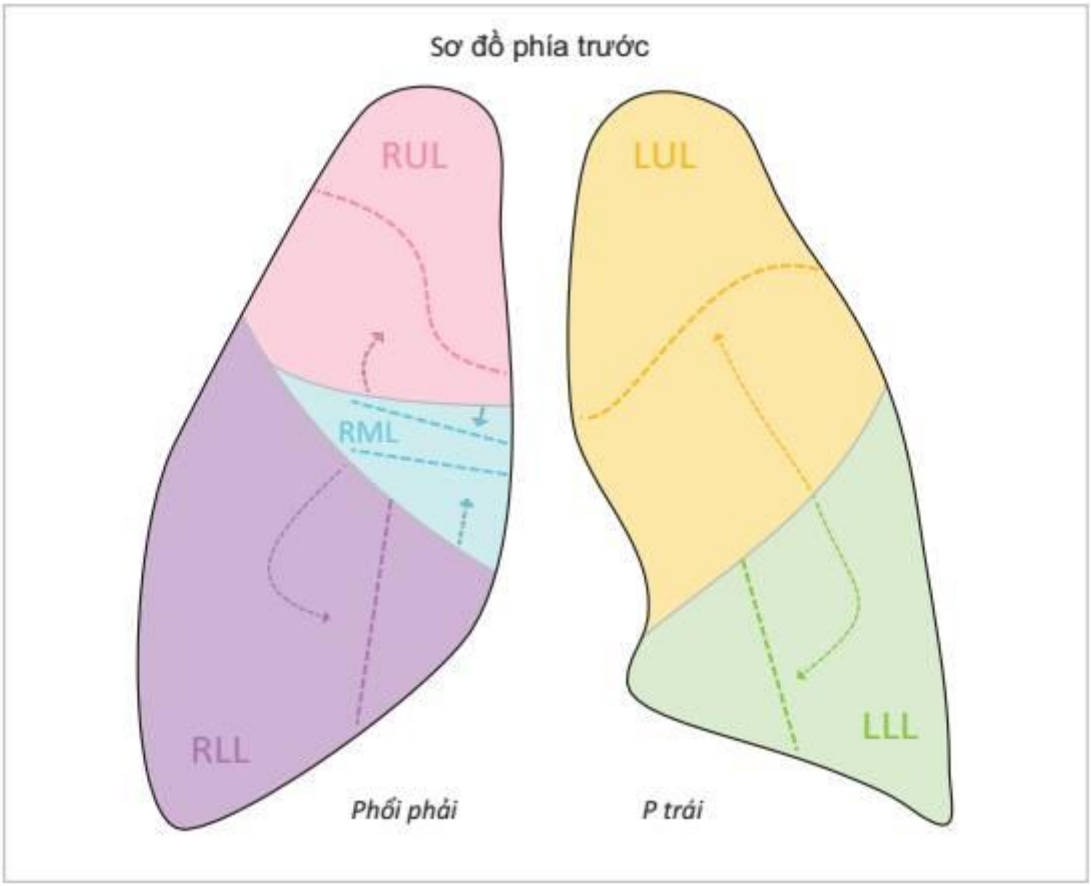
• Xẹp phổi do sẹo là khối lượng mất đi vì biến dạng của nhu mô phổi do xơ hóa.

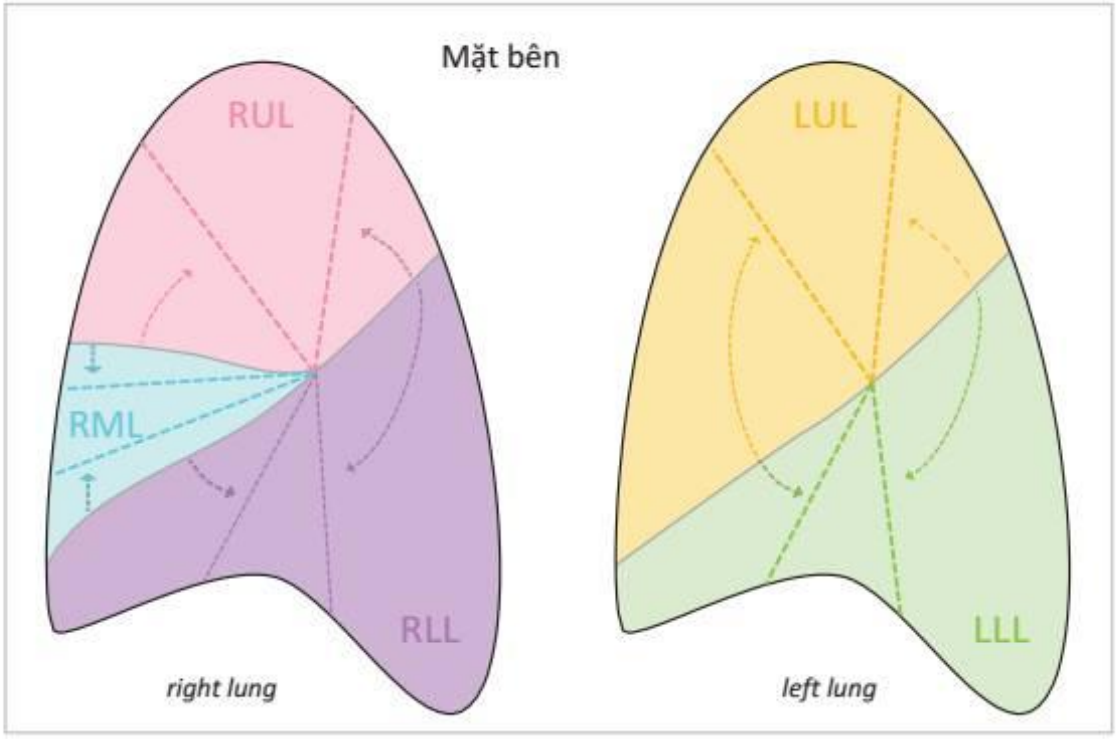
III) XẸP PHỔI THÙY.

• Xẹp phổi thùy thường do sự tắc nghẽn phế quản trung tâm (xẹp phổi tắc nghẽn) có thể do chất nhày lấp đầy hay khối u cản trở.
o Xẹp phổi thùy cấp tính nguyên nhân chủ yếu là do chất nhày bít tắc, nếu xẹp phổi gặp ở 1 bệnh nhân ngoại trú thì cần loại trừ u
o Xẹp phổi thùy hoặc toàn bộ thùy, có sự xuất hiện đặc trưng tại vị trí thùy trong 5 thùy của phổi.

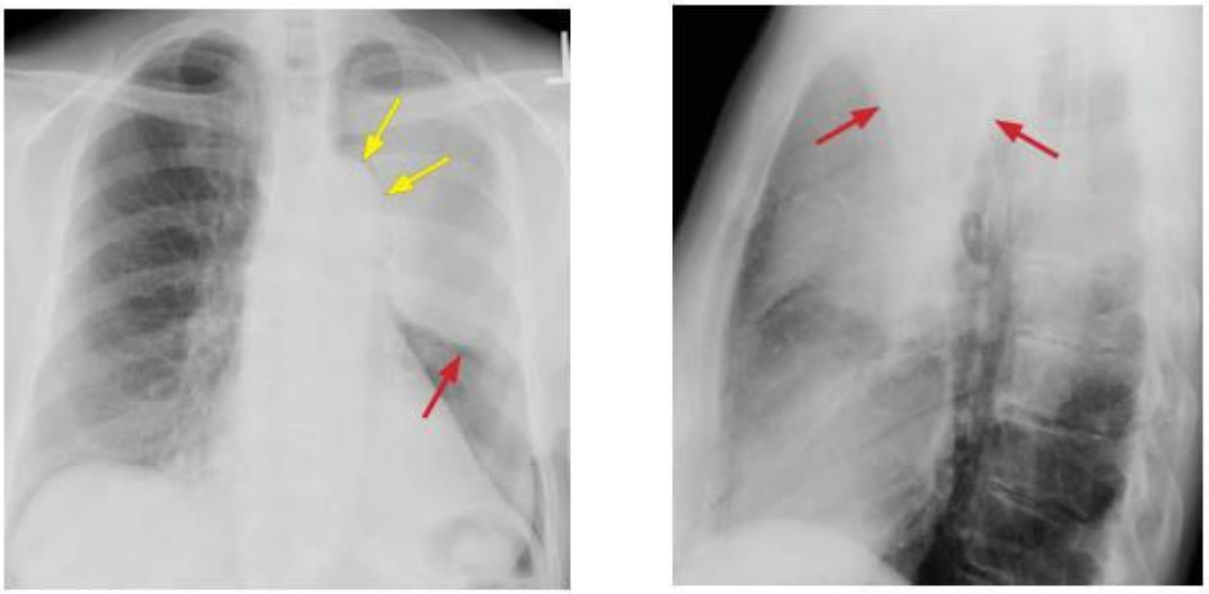
1) CÁC DẠNG XẸP THÙY PHỔI.

Mỗi thùy phổi khi xẹp sẽ theo hướng dự đoán như hình sau:





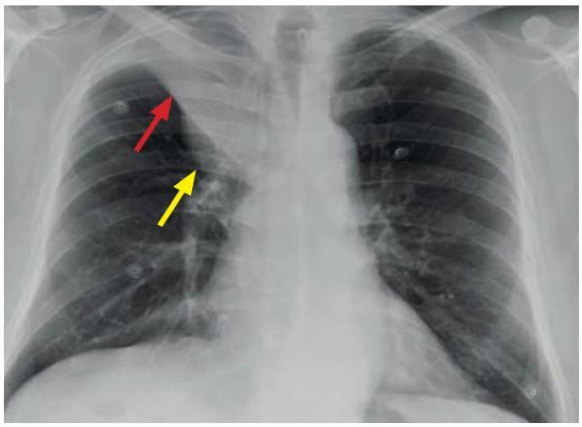
a. XẸP PHỔI THÙY TRÊN TRÁI

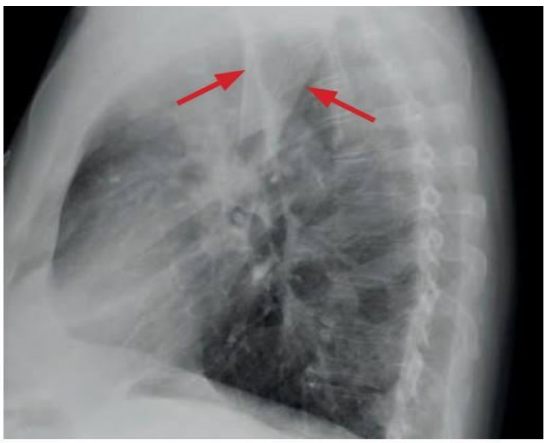


Xẹp thùy trên và dấu hiệu Luftsichel: XQ thẳng (ảnh trái) cho thấy 1 hình mờ thùy trên phổi che khuất phổi đặc trưng cho xẹp thùy trên phổi trái (mũi tên đỏ). Hình liềm sáng bên cung động mạch chủ là dấu hiệu Luftsichel (mũi tên vàng). Trên XQ nghiêng có hình chêm - xẹp thùy trên trái (hình phải).

• Dấu hiệu Luftsichel (liềm khí trong tiếng Đức) của xẹp thùy trên trái là hình ảnh liềm khí nhìn thấy trên XQ thẳng, đặc trưng cho phân cách của động mạch chủ và hạ phân thùy trên của thùy dưới tăng thể tích bù trừ. • Điều quan trọng là nhận ra xẹp thùy trên trái và không nhầm lẫn với đám mờ do viêm phổi, đặc biệt khi khối cản trở đường thở là nguyên nhân gây xẹp phổi.

b. XẸP THÙY TRÊN PHỔI PHẢI



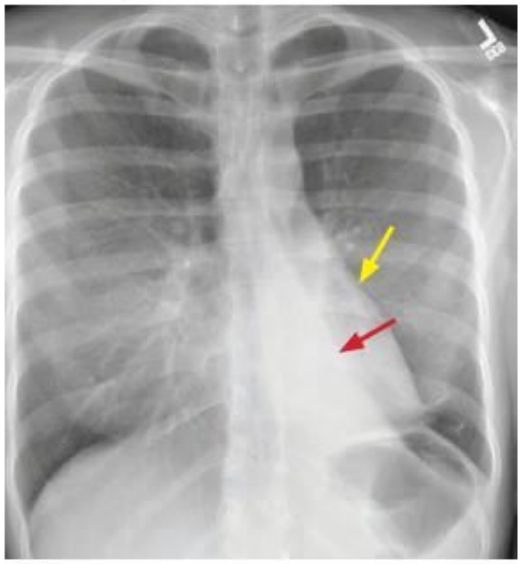


Xẹp thùy trên phải và dấu hiệu S golden's: XQ thẳng (ảnh trái) cho thấy đám mờ thùy trên phải với dịch chuyển rãnh liên thùy nhỏ (mũi tên đỏ) và 1 khối lồi ra (mũi tên vàng). XQ nghiêng cho thấy hình xẹp RUL và hình lồi ra nhỏ (mũi tên đỏ).

• Dấu hiệu S golden gặp trong xẹp thùy trên phải do u. Viền trung tâm của khối tạo hình dáng chữ S ngược. Mặc dù chữ S ngược nhưng người ta thường gọi là dấu hiệu S- Golden. Tương tự như xẹp thùy trên trái cần đặc biệt quan tâm tới 1 bệnh ác tính tiềm ẩn nhất là khi có dấu hiệu S-Golden.

• Dấu hiệu đỉnh gần cơ hoành là 1 đám mờ hình tam giác quanh cơ hoành nguyên nhân do sự co kéo cơ hoành từ rãnh phụ thấp hoặc dây chằng phổi dưới.

c. XẸP THÙY DƯỚI TRÁI

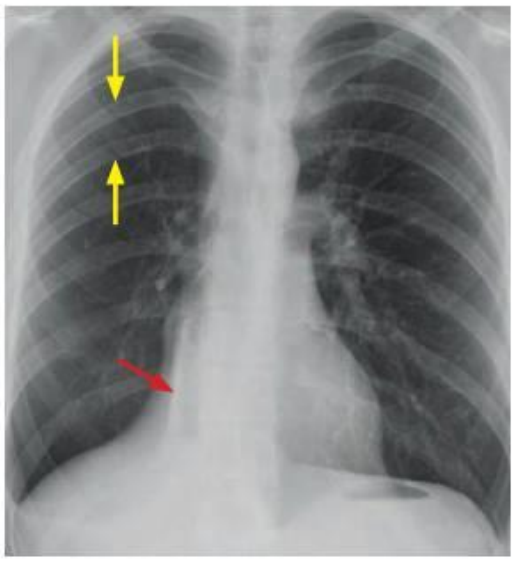


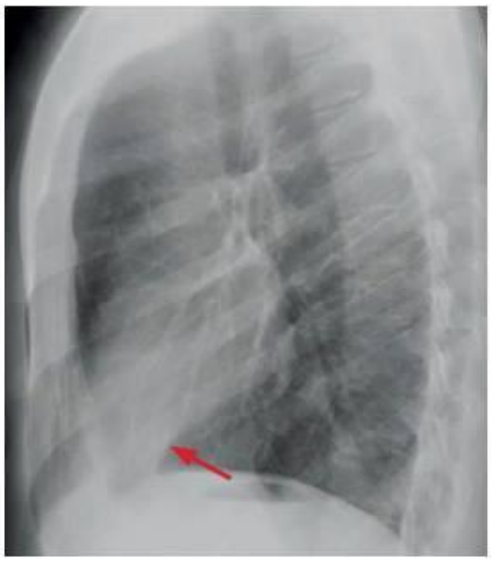


Xẹp thùy dưới trái: trên XQ thẳng và nghiêng là hình đám mờ hình tam giác sau tim đặc trưng xẹp thùy dưới trái (mũi tên đỏ). Hình ảnh mất mặt lõm của bờ tim trái (dấu eo phẳng, mũi tên vàng).

• Trong xẹp thùy dưới trái, tim hơi xoay và bị kéo xuống dưới. • Dấu eo phẳng mô tả sự làm phẳng bờ tim trái do co kéo rốn phổi và xoay tim.

d. XẸP THÙY DƯỚI PHẢI





Xẹp thùy dưới phải: XQ ngực thẳng thấy 1 đường định hướng theo chiều dọc bất thường cạnh bờ tim phải (mũi tên đỏ), tương ứng với 1 đám mờ hình nêm chiếu qua trung tâm trên phim nghiêng (mũi tên đỏ) đặc trưng xẹp thùy dưới phải. Trên XQ thẳng có tăng số lượng xương sườn tinh tế (mũi tên vàng) trong nửa trên lồng ngực do mất nhu mô.

- Xẹp thùy dưới phải là hình ảnh phản chiếu của xẹp thùy dưới trái
- Xẹpthùy dưới sẽ xuất hiện các đám mờ gần tim hình nêm.

e. XẸP THÙY GIỮA PHẢI





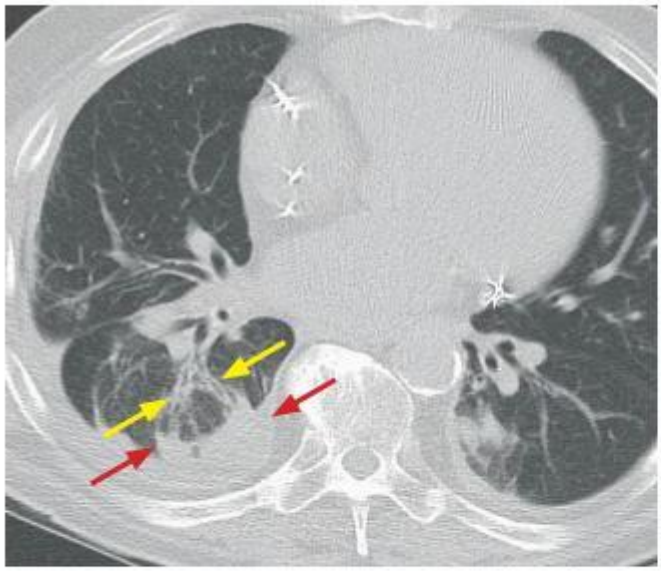
Xẹp thùy giữa phải: XQ phổi thẳng cho thấy 1 đám mờ đục không rõ ràng trong phổi đúng với tiêu cự bờ bóng tim phải (mũi tên). Nửa hoành phải bị nâng cao do mất thể tích phổi. XQ nghiêng thấy 1 đám mờ hình nêm giữa bóng tim đặc trưng cho xẹp thùy giữa phải.

• Xẹp phổi thùy giữa phải có thể phát hiện tinh tế trên X quang. Hình chiếu của bờ tim bên phải cạnh xẹp thùy giữa có thể là manh mối duy nhất . X quang nghiêng thấy đám mờ hình nêm ở phía trước.

2) XẸP PHỔI DẠNG VÒNG.

• Xẹp phổi dạng vòng là xẹp phổi có hình tròn luôn kèm theo bất thường màng phổi liền kề (ví dụ, tràn dịch màng phổi, dày màng phổi hoặc mảng bám, u màng phổi…).
• Xẹp phổi vòng hay gặp nhất ở phía sau thùy dưới.
• Tất cả năm đặc điểm này phải có trong chẩn đoán xẹp phổi dạng vòng:

1. Màng phổi liền kề phải có bất thường.
2. Đám mờ phải ở ngoại vi và liên quan với màng phổi.
3. Đám mờ phải tròn hoặc hình elip.
4. Mất nhu mô phải có mặt ở thùy bị ảnh hưởng.
5. Mạch phổi và phế quản dẫn vào đám mờ phải bị uốn cong - đây là dấu hiệu đuôi sao chổi.



Xẹp phổi vòng: CT thường thấy một đám mờ tròn ở giữa thùy dưới bên phải (mũi tên màu đỏ). Ví dụ này đáp ứng tất cả năm tiêu chí cho xẹp phổi vòng bao gồm: bất thường liền kề màng phổi (tràn dịch), đám mờ tiếp xúc với màng phổi, hình tròn, mất nhu mô ở thùy bị ảnh hưởng, và dấu hiệu đuôi sao chổi (mũi tên vàng) đặc trưng cho uốn cong mạch và phế quản bị ảnh hưởng tới trung tâm của xẹp phổi tròn.